

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO SANO EN LA SALA DE PARTOS

El nacimiento de un niño es un proceso natural, no por ello ausente de factores de riesgo.

En cada nacimiento deberá estar presente el personal adecuadamente capacitado y entrenado:

- que sepa lo que debe hacerse;
- que sea capaz de hacerlo;
- que trabaje en conjunto como un equipo coordinado.

Los profesionales que desarrollan sus actividades en la sala de partos deben estar capacitados para realizar la correcta recepción y reanimación del recién nacido.

Sala de recepción del recién nacido

La mesa de recepción del recién nacido debe estar ubicada en la misma sala de partos o en una habitación contigua y de fácil acceso. La temperatura ambiental donde se realice la atención del recién nacido deberá ser superior a los 28° C, inclusive en el quirófano. En caso de que se haya realizado una cesárea a la madre, la temperatura ambiental no deberá ser inferior a 24° C.

Una vez favorecido el contacto piel a piel del recién nacido con su madre y cortado el cordón umbilical, se colocará al niño debajo de una fuente de calor radiante para continuar con el secado corporal del bebé; el mismo deberá ser céfalo caudal, ya que la cabeza es la mayor superficie corporal en relación al peso.

Todas estas medidas son para evitar el daño por frío del neonato; debemos recordar que antes del nacimiento el neonato se encontraba en un medio acuático (líquido amniótico) con una temperatura igual a la materna, próxima a los 37° C. Al nacer se encuentra mojado, situación que favorece la pérdida de calor por evaporación.

Equipo e insumos

• Mesa de recepción:

Como se mencionó, deberá contar con una fuente de calor radiante, de fácil acceso lateral en caso de que sea necesaria la participación de más de un profesional para la realización de una reanimación completa. La mesa de recepción deberá contar además con un colchón duro de fácil limpieza y toallas limpias para el secado del bebé (Fig. N° 1).

La sala de recepción deberá contar con equipamiento que permita la aspiración de secreciones del neonato bajo distintas circunstancias. En general, los recién nacidos vitales no requieren la aspiración de la vía aérea superior y boca; en caso de ser necesario, se podrá utilizar una pera de goma, un aspirador eléctrico o un vacuómetro. Para la utilización de estos últimos, se deberán utilizar para la aspiración sondas número 9 o 10 F o K29. La aspiración deberá ser suave para no lesionar las mucosas y es necesaria su repetición en pocas oportunidades. En caso de ser necesaria, primero deberán aspirarse las fosas nasales y luego la boca.

En relación con las secreciones nasales y la permeabilidad nasal:

Las secreciones solo se aspirarán si son abundantes y dificultan la adaptación.

No es necesario el pasaje rutinario de una sonda a través de las fosas nasales.

Se deberá pasar en caso de malformaciones cráneo-faciales, detección del ingreso del aire en cada respiración exclusivamente a través de la boca.

Presencia de otras malformaciones.

• Equipo de bolsa y máscara:

Un porcentaje bajo de recién nacidos requiere de reanimación en sala de partos. A pesar de ello, en cada recepción deberán estar presentes los elementos necesarios para llevar adelante una reanimación completa (Fig. N° 2).

Fuente de oxígeno (tubo o ductos de oxígeno).

Medidor de flujo y tubuladura de PVC para administrar oxígenos a flujo libre.

Bolsa neonatal (capacidad 750 cc) con mecanismo de seguridad (válvula de liberación de presión o manómetro).

Máscaras para recién nacidos de término y prematuros, que deberán ser anatómicas, transparentes y acolchadas para no lesionar la cara del recién nacido.

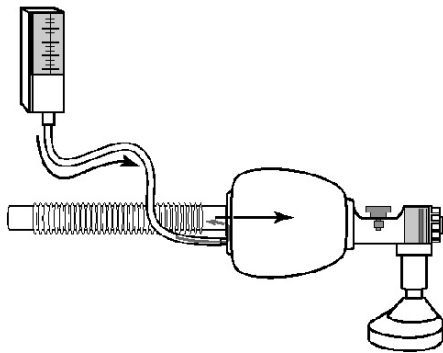
Sistema corrugado de enriquecimiento del aire inspirado.

Saturómetro.



FIGURA 1. Fuente de calor radiante (servocuna)

FIGURA 2



1. Medidor de flujo de oxígeno.
2. Tubuladura de PVC.
3. Bolsa de reanimación neonatal.
4. Mecanismo de seguridad.
5. Máscara.
6. Sistema corrugado de enriquecimiento del aire inspirado.

• **Equipo para la intubación traqueal:**

Laringoscopio con hoja recta N° 0 y N° 1 para recién nacidos prematuros y a término respectivamente (Fig. N° 3).

Tubos endotraqueales N° 2,5; 3; 3,5; y 4 mm de diámetro interno (deberán ser transparentes, radiopacos, con marcas cada 1 cm en su longitud (Fig N° 4).

Cinta adhesiva para la fijación del tubo endotraqueal sobre el labio superior, ya que los tubos endotraqueales para los recién nacidos no deben tener balón de fijación (Figura N° 5).

Estetoscopio

Medicamentos:

Adrenalina ampolla 1:10.000

Solución fisiológica

Dextrosa al 10%

Elementos para la canalización umbilical:

Catéteres umbilicales para canalización de arteria y vena

Solución antiséptica

Llaves de tres vías

Jeringas de 2,5; 5; 10; 20 cm.

Aguja, lino 100, etc.

FIGURA 3. (1) Laringoscopio rama N° 1; (2) rama N° 2.

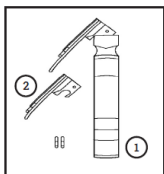


FIGURA 4. (3) Tubos endotraqueales N° 2,5; 3; 3,5; 4 mm.

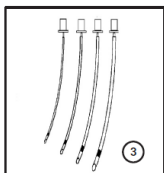
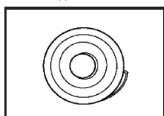


FIGURA 5. (3) Cinta adhesiva.



Atención en sala de partos del recién nacido vigoroso

Una vez producido el nacimiento, deberá colocarse al recién nacido sobre el abdomen de su madre (parto Levoier) Fig N° 6, para favorecer el contacto piel a piel inmediato entre ellos, mientras se los seca con compresas secas y tibias, y se brinda estimulación táctil para favorecer el llanto. Las compresas se cambian a medida que se humedecen. Todo esto se realiza mientras se espera el tiempo suficiente para ligar y cortar el cordón umbilical. En muchas oportunidades, después del nacimiento se coloca al bebé sobre una mesa acolchada alta hasta que se liga y corta el cordón umbilical.

Ligadura oportuna del cordón umbilical

Cuando se realiza la ligadura del cordón umbilical al tercer minuto de vida el volumen de sangre transfundido desde la placenta al recién nacido aumenta hasta un 32%. El 80% de este volumen pasa durante el primer minuto con un aporte aproximado de 35 ml de sangre por kilo.

Se pueden ganar hasta 50 mg de hierro para llenar los depósitos al nacer y así prevenir su deficiencia en el primer año de vida.

Se ha calculado que, en niños de término en quienes la ligadura del cordón se realiza en forma adecuada, los requerimientos de hierro hasta el año de vida se reducen a la mitad, comparados con aquellos en quienes la ligadura se realiza en forma inmediata (antes del primer minuto de vida).

Aspiración de secreciones y permeabilidad nasal

Las secreciones solo se aspirarán si son abundantes y dificultan la adaptación.

NO es necesario el pasaje rutinario de una sonda a través de las fosas nasales.

Se deberá pasar, en caso de malformaciones cráneo-faciales, ingreso del aire a través de la boca con las respiraciones.

Presencia de otras malformaciones.

La evaluación inicial del recién nacido en sala de partos, para considerar vitalidad y continuar con los procedimientos de rutina en la recepción del recién nacido sano o comenzar con los pasos iniciales de la reanimación del recién nacido, comprende la observación de:

Esfuerzo respiratorio.

Frecuencia cardíaca.

Tono muscular.

Por otro lado, a todo recién nacido vital o que haya requerido reanimación básica o avanzada, se le realizará el puntaje de Apgar, el cual consiste en un examen rápido que se realiza al primero y quinto minuto de vida después del nacimiento del bebé. El puntaje en el minuto 1 determina qué tan bien tolera el bebé el proceso de nacimiento, mientras que el puntaje al minuto 5 evalúa qué tan bien se está adaptando el recién nacido a la vida extrauterina.

Se evalúan cinco categorías:

Esfuerzo respiratorio.

Frecuencia cardíaca.

Tono muscular.

Reflejos.

Color de la piel.

A su vez, el puntaje que se otorgará en cada categoría dependerá de la condición observada y se asignará un valor de 0 a 2 (Tabla N° 1).

Examen físico del recién nacido en sala de partos

Debe ser sistemático y completo; se recomienda que este sea en dirección cefalo caudal, procurando evaluar el proceso de transición y descartar malformaciones congénitas que puedan ser detectadas mediante el examen físico inicial.

Permeabilidad esofágica y anal

NO es necesario el pasaje rutinario de una sonda orogástrica para evaluar permeabilidad esofágica.

NO es necesario el pasaje rutinario de una sonda a través del esfínter anal para evaluar su permeabilidad.

¿Cuándo deben realizarse estas prácticas?

Antecedente de polihidramnios.

Presencia de otras malformaciones.

Diagnóstico prenatal de cardiopatía congénita.

Malformaciones perineales mayores.

Implantación anormal del ano.

Presencia de fistulas rectocutáneas.

Administración de vitamina K

La administración de vitamina K en sala de partos tiene como objetivo el reducir el riesgo de enfermedad hemorrágica del recién nacido, por lo cual se administrará una dosis única de 1 mg de vitamina K independiente del peso de nacimiento del recién nacido, por vía intramuscular en la cara anterolateral del muslo.

Vacunación contra hepatitis B

Se administrará obligatoriamente y sin contraindicaciones dentro de las primeras 12 h de vida del recién nacido. En aquellas embarazadas en las que se desconoce el estado serológico para hepatitis B, la vacunación del neonato en este periodo reduce en más de un 97% el riesgo de transmisión vertical de hepatitis B en caso de portador crónico de la mujer.

Peso de nacimiento

Se considera peso de nacimiento a aquel medido dentro de la primera hora de producido el nacimiento con el bebé desprovisto de ropa. La medición deberá expresarse en gramos, por ejemplo, 3150 gramos. Se prefieren las balanzas de palanca con posibilidad de realizar graduaciones cada 10 gramos frente a las electrónicas.

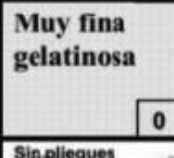
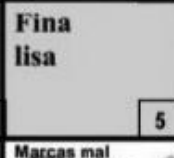
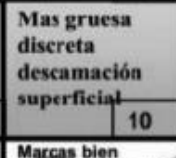
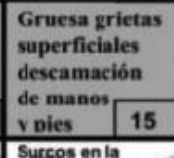
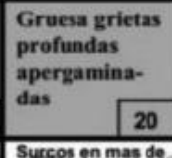
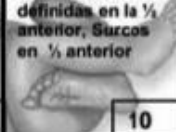
Determinación de la edad gestacional

Para la determinación de la edad gestacional en sala de partos se utilizan características somáticas y neurológicas del recién nacido. Existen varias tablas para la determinación de la edad gestacional después del nacimiento. La más utilizada de ellas para los recién nacidos a término es el Método de Capurro, que en su versión simplificada utiliza cinco características somáticas del recién nacido y suprime parámetros neurológicos (Tabla N° 2).

TABLA 1. Puntaje de Apgar.

PUNTAJE	0	1	2
FRECUENCIA CARDÍACA	AUSENTE	MENOS 100	100 O MÁS
ESFUERZO RESPIRATORIO	AUSENTE	LLANTO DÉBIL	LLANTO VIGOROSO
TONO MUSCULAR	FLACIDEZ TOTAL	CIERTA FLEXIÓN DE EXTREMIDADES	BIEN FLECCIONADAS
IRRITABILIDAD REFLEJA	SIN RESPUESTA	ALGÚN MOVIMIENTO	TOS, MUECAS, ESTORNUDOS
COLOR	CIANOSIS GENERALIZADA	CUERPO ROSADO Y EXTREMIDADES AZULES	ROSADO

TABLA 2. Método de Capurro.

Forma de la OREJA (Pabellón)	 Aplanada, sin incurvación 0	 Borde superior parcialmente incurvado 8	 Todo el borde superior incurvado 16	 Pabellón totalmente incurvado 24	
Tamaño de GLÁNDULA MAMARIA	 No Palpable 0	 Palpable menor de 5 mm. 5	 Palpable entre 5 y 10 mm. 10	 Palpable mayor de 10 mm. 15	
Formación del PEZON	 Apenas visible sin areola 0	 Diámetro menor de 7.5 mm. Areola lisa y chata 5	 Diámetro mayor de 7.5 mm. Areola punteada Borde No levantado 10	 Diámetro mayor de 7.5 mm. Areola punteada Borde levantado 15	
TEXTURA de la PIEL	 Muy fina gelatinosa 0	 Fina lisa 5	 Mas gruesa discreta descamación superficial 10	 Gruesa grietas superficiales descamación de manos y pies 15	 Gruesa grietas profundas apegaminadas 20
PLIEGUES PLANTARES	 Sin pliegues 0	 Marcas mal definidas en la mitad anterior 5	 Marcas bien definidas en la 1/2 anterior. Surcos en 1/2 anterior 10	 Surcos en la mitad anterior 15	 Surcos en mas de la mitad anterior 20

Para realizar el cálculo de la edad gestacional, se procede a sumar el resultado de las características somáticas seleccionadas al número 204; el resultado obtenido es igual a la duración de la gestación en días, dividido por 7 nos dará la edad gestacional en semanas

Clasificación de los recién nacidos según la edad gestacional

Recién nacidos pretérmino:

Aquellos cuya edad gestacional al nacimiento es menor de 37 semanas.

Recién nacidos de término:

Aquellos cuya edad gestacional al nacimiento se encuentra entre las 37 y las 42 semanas.

Recién nacidos de postérmino:

Aquellos cuya edad gestacional al nacimiento es mayor de 42 semanas.

Baño

No es necesario el baño rutinario de los recién nacidos en la sala de recepción, solo se realiza por estética para descartar restos de unto sebáceo o sangre. La indicación se limita a los recién nacidos hijos de mujeres que conviven con el VIH para reducir el riesgo de transmisión vertical de VIH.

Identificación del recién nacido

La Legislación Argentina dice al respecto que la identificación del recién nacido debe realizarse antes de efectuar el corte del cordón umbilical en sala de partos. Se realiza la impresión de las huellas plantares del niño y digitales de la madre. Además la madre y su hija/o deben salir juntos de la sala de partos.

Autor

Dr. Norberto E. Santos.

Neonatólogo. Servicio de Neonatología Hospital de Niños de La Plata.

Ayudante diplomado rentado Cátedra de Pediatría B. Facultad de Ciencias Médicas. UNLP.